

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Salud del Paciente - 15 (PHQ-15)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario de Salud del Paciente - 15
Sigla	PHQ-15
Autores	Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W.
Año	2002
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Somatización y ansiedad por la salud
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Rosendal et al., 2005)
Acceso/licencia	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Nota curatorial de derechos	Reproduccion permitida; se archiva validacion OA.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Somatización y ansiedad por la salud. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	Unidimensional (Síntomas somáticos generales).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	15 ítems (incluyendo dolor, fatiga, gastrointestinal, etc.).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 3 puntos (0 = Nada, 1 = Un poco, 2 = Mucho).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Unidimensional (Síntomas somáticos generales).
Ítems	15 ítems (incluyendo dolor, fatiga, gastrointestinal, etc.).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 3 puntos (0 = Nada, 1 = Un poco, 2 = Mucho).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria (0 a 30).

Regla de corrección	Sumatoria (0 a 30).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntos de corte de severidad somática: 5 (Leve), 10 (Moderada), 15 (Severa). Útil para Trastorno de Síntomas Somáticos.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa la gravedad de los síntomas somáticos. Excelente validez convergente y consistencia interna (.80).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa la gravedad de los síntomas somáticos. Excelente validez convergente y consistencia interna (.80).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Rosendal et al., 2005)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Somatización y ansiedad por la salud en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W.; 2002.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Rosendal et al., 2005)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Somatización y ansiedad por la salud
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 15 ítems (incluyendo dolor, fatiga, gastrointestinal, etc.); Unidimensional (Síntomas somáticos generales).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria (0 a 30).
Interpretación	Puntos de corte de severidad somática: 5 (Leve), 10 (Moderada), 15 (Severa). Útil para Trastorno de Síntomas Somáticos.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2002). Cuestionario de Salud del Paciente - 15.

Fuente de referencia del catálogo: [PHQ Screeners](https://www.phqscreeners.com/)

<https://www.phqscreeners.com/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21188674/>

<https://www.phqscreeners.com/select-screener>

<https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/download/438/644/659>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	PHQ-15 español, 15 síntomas. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 001ed017cbd2d2a33f263778fbfa8885adbb7adefec5688339c8fb1ca279a184.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	PHQ-15 español, 15 síntomas.
6. Periodo temporal	Últimas cuatro semanas.
7. Escala/formato de respuesta	0=Nada a 2=Mucho.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar 15 síntomas 0–2; rango 0–30. Verificar en la forma la regla especial de síntomas menstruales y no imputar faltantes sin instrucción explícita.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntos de corte de severidad somática: 5 (Leve), 10 (Moderada), 15 (Severa). Útil para Trastorno de Síntomas Somáticos. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	El formulario local declara permiso general de reproducción/traducción/distribución; conservar texto y atribución.
13. Referencias y fuentes verificadas	Ros-Montalbán et al., DEPRE-SOMA, https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/view/438 ; formulario español local PHQ Screeners.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.